Клинические рекомендации

# Абсцесс, фурункул и карбункул носа

Конспект для врача-оториноларинголога

| | |
|---|---|
| Коды МКБ-10 | **J34.0** — Абсцесс, фурункул и карбункул носа |
| Пациенты | взрослые, дети |
| Рекомендация | опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.10.2025, пересмотр не позднее 2028 года |
| Разработчик | Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов |
| Полный текст | cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/956_1 |

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

## Оглавление


**1. Основные положения** 3

**2. Клиническая картина и классификация** 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология 4

2.3 Патогенез 4

2.4 Классификация 4

2.5 Клиническая картина 5

2.6 Анамнез 5

**3. Диагностика** 6

3.1 Первичный осмотр 6

3.2 Передняя риноскопия 6

3.3 Признаки внутричерепных осложнений (оценивают при каждом осмотре) 6

3.4 Компьютерная томография головного мозга с контрастированием 7

3.5 Консультации специалистов 7

3.6 Общий анализ крови 7

3.7 Биохимический анализ крови 8

3.8 Коагулограмма 8

3.9 Бактериологическое исследование гнойного отделяемого 8

**4. Лечение** 8

4.1 Стадия инфильтрации: консервативное лечение 9

4.2 Системная антибактериальная терапия (все пациенты) 11

4.3 Стадия абсцедирования, карбункул, абсцесс: хирургическое лечение 13

4.4 Осложнённое течение: антикоагулянтная терапия 13

4.5 Стадия разрешения 13

**5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации** 13

5.1 Рецидивирующее течение 13
5.2 Профилактика 14
5.3 Показания к госпитализации 14
**6. Источник и актуальность 15**
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 15

## 1. Основные положения

- Лечение по стадиям:
  1. стадия инфильтрации: консервативное лечение;
  2. абсцедирование и карбункул: вскрытие и дренирование гнойника без прекращения консервативной терапии.
- При фурункуле, карбункуле и абсцессе носа во всех случаях необходима системная антибактериальная терапия, направленная на санацию очага инфекции и профилактику осложнений.
- При каждом осмотре исключают признаки внутричерепных осложнений:
  1. синдром системной воспалительной реакции;
  2. неврологическая симптоматика;
  3. офтальмологическая симптоматика;
  4. тромбоз угловой вены и кавернозного синуса.
- Внутрь применяют амоксициллин + клавулановую кислоту (взрослым 875/125 мг 2 раза в сутки, 7 дней); для парентерального введения препаратом первой линии является цефазолин.
- Местно всем пациентам применяют антисептики и мази с антибиотиками (мупироцин, фузидовая кислота).
- При подозрении на тромбоз кавернозного синуса показана компьютерная томография (КТ) головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием; признаки тромбоза приведены во вкладке «Диагностика».
- Госпитализация:
  1. дети: во всех случаях, в круглосуточный оториноларингологический стационар;
  2. взрослые в стадии инфильтрации могут лечиться амбулаторно.
- Массаж области носа и выдавливание содержимого фурункула противопоказаны.

## 2. Клиническая картина и классификация

### 2.1 Определения

1. фурункул носа: острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула и сальной железы на кончике или крыльях носа, в преддверии носа или в области дна носа у верхней губы;
2. карбункул носа: гнойно-некротическое воспаление нескольких волосяных фолликулов и сальных желёз с распространением вглубь и по поверхности, с обширными некрозами кожи и подкожной клетчатки;
3. абсцесс носа (абсцедирующий фурункул): скопление гноя при острой инфекции с деструкцией тканей в очаге, часто с перифокальным отёком.

### 2.2 Этиология

Ведущая роль в возникновении фурункула и карбункула носа принадлежит золотистому стафилококку; доказанным резервуаром инфекции и источником заражения служат его бессимптомные носители. Стрептококки, прежде всего бета-гемолитический стрептококк группы А, также могут вызывать пиодермии кожи и фурункул носа.

**Факторы риска инфицирования волосяного фолликула**

1. микротравмы кожи носа и преддверия носа;
2. загрязнение кожи техническими маслами и пылью при несоблюдении личной гигиены;
3. состояния, снижающие местный иммунитет кожи: переохлаждение, перегревание, стресс, нарушение секреторной функции кожи.

У детей предрасполагающим фактором чаще служат микротравмы кожи преддверия носа при «ковырянии» в носу и чрезмерном сморкании.

Фурункул носа нередко является проявлением фурункулёза, то есть образования множественных фурункулов на фоне вторичного иммунодефицита при эндокринных заболеваниях, прежде всего при сахарном диабете, а также при гиповитаминозе, нарушениях питания и заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

### 2.3 Патогенез

Опасным треугольником называют среднюю зону лица, ограниченную линиями, которые соединяют назион с углами рта. Венозная кровь от неё оттекает к кавернозному синусу через угловые вены, вены орбиты и крыловидное венозное сплетение.

Вены этой системы лишены клапанов, поэтому кровь может оттекать в полость черепа. Инфекция с кожи лица, наружного носа, полости носа и околоносовых пазух гематогенно распространяется в глазницу, далее в кавернозный синус и на головной мозг.

**Структуры, проходящие через кавернозный синус и прилежащие к нему**

1. внутренняя сонная артерия;
2. III, IV и VI пары черепных нервов;
3. первая и вторая ветви тройничного нерва;
4. гипофиз и клиновидная пазуха (прилежат к стенкам синуса).

Эти анатомические особенности могут стать причиной грозных жизнеугрожающих внутричерепных осложнений.

При снижении сопротивляемости организма и высокой вирулентности возбудителя возможна генерализация процесса: стафилококки распространяются в окружающие ткани или проникают в кровоток с развитием сепсиса. В зоне инфильтрата развивается тромбоз мелких вен, и увеличение воспалительного очага повышает угрозу распространения тромбоза.

### 2.4 Классификация

**Стадии**

1. I стадия: инфильтрация;
2. II стадия: абсцедирование.

### 2.5 Клиническая картина

**Жалобы**

1. боль в области носа;
2. головная боль;
3. слабость, снижение работоспособности;
4. повышение температуры тела до субфебрильных значений.

В общем анализе крови возможны сдвиг лейкоцитарной формулы влево и повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Фурункул может локализоваться на кончике носа, в преддверии носа, вблизи перегородки носа или в области дна носа.

**Стадия инфильтрации**

1. постепенно нарастающая гиперемия кожи над фурункулом;
2. локальная боль, усиливающаяся при мимических движениях и жевании;
3. нарастающая инфильтрация мягких тканей;
4. вокруг первичного очага некротическая ткань, формируется стержень фурункула;
5. на внутренней поверхности входа в нос болезненный конусовидный инфильтрат.

При благополучном течении происходит отторжение некротического стержня с выделением небольшого количества гноя, инфильтрат уменьшается, болевой синдром регрессирует, температура тела нормализуется, общее состояние улучшается.

**Стадия абсцедирования**

1. зона некроза увеличивается;
2. кожа над инфильтратом истончается;
3. появляется флюктуация, формируется абсцесс.

**Карбункул и абсцесс носа**

1. тяжёлое общее состояние, фебрильная лихорадка;
2. ощущение распирания и выраженная пульсирующая боль;
3. несколько плотных инфильтратов, сливающихся в единый увеличивающийся очаг;
4. обширная полость с гнойно-некротическим содержимым;
5. несколько отверстий на коже, из которых выделяются гной и некротизированные кровянистые массы.

У детей заболевание протекает тяжелее вследствие выраженного интоксикационного синдрома (головная боль, слабость, вялость, лихорадка). Местные изменения могут развиваться стремительнее, а обширный отёк и гиперемия верхней губы или щёчной области могут маскировать фурункул под заболевание челюстно-лицевой области.

### 2.6 Анамнез

В анамнезе возможны указания на переохлаждение и косметические процедуры в области наружного носа и его преддверия.

## 3. Диагностика

Диагноз устанавливают по трём критериям.

**Жалобы**

1. выраженная боль в области очага, усиливающаяся при прикосновении;
2. головная боль, недомогание;
3. повышение температуры тела.

**Данные осмотра**

1. гиперемия, отёк и инфильтрация мягких тканей наружного носа, преддверия носа и носо-лицевой области;
2. резкая болезненность при пальпации.

**Передняя риноскопия**

1. в преддверии носа у волосяного фолликула гиперемия кожи, инфильтрат и гнойный стержень в центре.

### 3.1 Первичный осмотр

**Показания**

1. каждый пациент с подозрением на фурункул носа: первичный осмотр оториноларинголога, врача общей практики или педиатра.

**Наружный осмотр**

1. гиперемия, отёк и болезненность в области преддверия и кончика носа;
2. прикосновение к носу и риноскопия болезненны;
3. кожа преддверия может быть покрыта толстыми жёлтыми корками;
4. при выраженном воспалении отёк распространяется на щёчную область и верхнюю губу.

### 3.2 Передняя риноскопия

Основной метод инструментальной диагностики, выполняется всем пациентам: уточняет локализацию фурункула.

**Диагностические признаки в динамике**

1. начало: остиофолликулит преддверия носа, гиперемия и уплотнение в устье волосяного фолликула;
2. в течение **1–2 суток**: отёк, инфильтрация и гиперемия кожи входа в нос (стадия инфильтрации);
3. затем кожа истончается, ткани в очаге гнойно-некротически расплавляются с образованием детрита.

### 3.3 Признаки внутричерепных осложнений (оценивают при каждом осмотре)

При каждом осмотре необходимо оценивать наличие симптомов внутричерепных осложнений, которые объединяются в три синдрома: инфекционный, неврологический и офтальмологический.

**Инфекционный синдром (синдром системной воспалительной реакции)**

1. температура тела **38 °C и выше** или **36 °C и ниже**;
2. частота сердечных сокращений **90 в минуту и более**;
3. частота дыхания **более 20 в минуту**;
4. лейкоциты более 12 × $10^9$/л или менее 4 × $10^9$/л либо незрелых форм более 10%;
5. прокальцитонин в плазме **0,5 нг/мл и выше**.

**Неврологический синдром**

1. интенсивная головная боль;
2. тошнота и рвота, не связанные с приёмом пищи;
3. несистемное головокружение;
4. менингеальный синдром: светобоязнь, звукобоязнь, гиперестезия кожи, ригидность затылочных мышц; симптомы Кернига и Брудзинского, скуловой симптом Бехтерева, симптом Менделя;
5. при прогрессировании оглушение, психомоторное возбуждение, судорожный синдром.

**Офтальмологический синдром**

1. отёк век на стороне поражения;
2. хемоз;
3. экзофтальм;
4. болезненные тромбированные вены при пальпации век;
5. при офтальмоскопии признаки внутричерепной гипертензии.

**Тромбоз угловой вены**

1. резкая болезненность при пальпации;
2. интенсивная головная боль;
3. отёк лица на стороне поражения;
4. угловая вена пальпируется в виде плотного болезненного тяжа.

**Тромбоз кавернозного синуса**

1. на начальном этапе выраженный цианоз слизистой оболочки губ, кожи лба и носа;
2. нарастающий отёк верхней губы и щеки на стороне поражения с распространением на височную и лобную области, веки и противоположную половину лица;
3. нарушение функции глазодвигательного, блокового, отводящего и тройничного нервов вплоть до полного выпадения.

### 3.4 Компьютерная томография головного мозга с контрастированием

**Показания**

1. подозрение на тромбоз кавернозного синуса: КТ головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием.

О возможном тромбозе кавернозного синуса свидетельствуют фебрильная лихорадка, головная боль, хемоз, экзофтальм и признаки поражения III, IV, V и VI пар черепных нервов.

### 3.5 Консультации специалистов

**Показания**

1. осложнённое течение: первичные консультации офтальмолога и невролога.

При распространении воспалительного процесса на область лица целесообразна консультация челюстно-лицевого хирурга.

Алгоритм ведения пациента (приложение Б) при внутричерепных осложнениях предусматривает консультации нейрохирурга, офтальмолога и челюстно-лицевого хирурга.

> Состав консультантов при осложнениях в разных разделах рекомендации не совпадает: в разделе 2.5 и в критериях качества указаны невролог и офтальмолог, в алгоритме (приложение Б) указаны нейрохирург, офтальмолог и челюстно-лицевой хирург.

### 3.6 Общий анализ крови

Выполняется всем пациентам на любой стадии для оценки общего состояния и выраженности воспаления.

### 3.7 Биохимический анализ крови

**Показания**

1. выявление сахарного диабета, нарушений углеводного обмена и других состояний, способствующих развитию фурункула и утяжеляющих его течение.

**Оценка результатов**

1. сахарный диабет неблагоприятно влияет на частоту развития, течение и прогноз фурункула;
2. повышен уровень глюкозы: направить к эндокринологу для коррекции гликемии, выявления сахарного диабета и назначения лечебного питания;
3. изменения билирубина, креатинина, мочевины, активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ): нарушение функции печени и почек.

### 3.8 Коагулограмма

**Показания**

1. осложнённое течение;
2. сопутствующие заболевания.

### 3.9 Бактериологическое исследование гнойного отделяемого

Посев гнойного отделяемого на аэробную и факультативно-анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам.

**Показания**

1. абсцедирующий фурункул;
2. карбункул;
3. абсцесс носа.

Материал забирают из раны после вскрытия, без контакта с окружающими тканями, до начала антибактериальной терапии.

---

## 4. Лечение

1. метод лечения определяется стадией и характером проявлений, в том числе наличием карбункула или абсцесса;
2. при неосложнённом течении лечение преимущественно консервативное: местное и парентеральное;
3. лечение комплексное: элиминация возбудителя, купирование интоксикации, восстановление обмена веществ, повышение защитных сил организма.

По алгоритму ведения пациента (приложение Б):

1. стадия инфильтрации: консервативное лечение;
2. стадия абсцедирования: хирургическое лечение в сочетании с консервативным;
3. стадия разрешения: консультация физиотерапевта;
4. рецидив: консультации эндокринолога и аллерголога-иммунолога.

### 4.1 Стадия инфильтрации: консервативное лечение

Для подавления инфекции и воспаления у всех пациентов с фурункулом носа местно применяют антисептики.

1. в первые часы после появления инфильтрата: повторное смазывание пустулы 5% спиртовым раствором йода;
2. выраженное действие: четвертичные аммониевые соединения (бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний), препараты йода, хлоргексидин; допустимы у взрослых и детей;
3. повидон-йод разрешён детям **старше 28 дней**;
4. кратность обработки по выраженности воспаления, обрабатывают до разрешения инфекционного процесса;
5. в стадии инфильтрации кожу вокруг очага бережно обрабатывают 70% этанолом.

При фурункуле и карбункуле носа для санации очага местно используют мази с антибиотиками широкого спектра действия.

**Мупироцин, мазь**

1. взрослые: 2–3 раза в день, 5–7 дней;
2. дети с рождения: 2–3 раза в день, не более 10 дней.

**Фузидовая кислота**

1. взрослые: мазь или крем на кожу над фурункулом до 3–4 раз в день, 7–14 дней;
2. дети с рождения: крем 3–4 раза в день, 7–14 дней.

**Диоксометилтетрагидропиримидин + хлорамфеникол, мазь: противомикробное и противовоспалительное действие**

1. взрослые и дети с одного года: один раз в день до очищения раны от гнойно-некротических масс.

Для купирования воспаления и болевого синдрома при отсутствии противопоказаний рекомендуется противовоспалительная и обезболивающая терапия.

НПВП и другие анальгетики-антипиретики в монотерапии или в комбинации; выраженный эффект даёт сочетание НПВП с парацетамолом.

Метамизол натрия купирует болевой синдром у взрослых и детей, в том числе в послеоперационном периоде.

**НПВП у детей**

1. ибупрофен: с 3 месяцев;
2. кетопрофен: с 15 лет;
3. кетопрофен, гранулы для приготовления раствора внутрь: с 6 лет.

В амбулаторной практике от назначения метамизола натрия детям следует воздержаться; в стационаре препарат применяется только при отсутствии других анальгетиков, разрешённых к применению у детей, в связи с риском серьёзных нежелательных явлений.

**Анальгетическая терапия у взрослых**

| Препарат | Разовая доза | Интервал | Максимум в сутки | Длительность |
|---|---|---|---|---|
| **Парацетамол** | 0,5–1 г внутривенно, инфузия в течение 15 минут | 6 ч | 4 г | 5–7 суток |
| **Диклофенак** | 75 «мл» внутримышечно (так в таблице рекомендации; по смыслу 75 мг) | 12 ч | 150 мг | 2 суток |

| Препарат | Разовая доза | Интервал | Максимум в сутки | Длительность |
|---|---|---|---|---|
| **Кеторолак** | 30 мг внутривенно или внутримышечно | 8 ч | 60–90 мг | 2 суток |
| **Кетопрофен** | 100 мг внутривенно или внутримышечно | 12 ч | 200 мг | не более 2 суток |
| **Лорноксикам** | 8 мг внутривенно или внутримышечно | 12 ч | 16 мг | 1–7 суток |
| **Декскетопрофен** | 50 мг внутривенно или внутримышечно | 8–12 ч | 150 мг | 2 суток |
| **Метамизол натрия** | 500–1000 мг внутривенно или внутримышечно | 8–12 ч | 2 г | 1–5 суток |

> Разовая доза диклофенака в таблице 1 указана как «75 мл в/м»; исходя из смысла и суточного максимума 150 мг, речь идёт о 75 мг.

### Анальгетическая терапия у детей

| Препарат | Разовая доза | Интервал | Максимум в сутки | Длительность |
|---|---|---|---|---|
| **Парацетамол внутривенно** | Инфузия в течение 15 минут: менее 10 кг — 7,5 мг/кг; 10–50 кг — 15 мг/кг; более 50 кг — 1000 мг | 4 ч | Менее 10 кг — менее 30 мг/кг; 10–50 кг — менее 60 мг/кг, но не более 2 г; 33–50 кг — менее 60 мг/кг, но не более 3 г; более 50 кг — 4 г | 5–7 суток |
| **Парацетамол внутрь** | С 12 лет — 0,5–1 г; 6–12 лет — 240–480 мг; 1–6 лет — 120–240 мг; от 3 месяцев до года — 72–120 мг | 6 ч | С 12 лет — 4 г; 33–50 кг — менее 60 мг/кг, но не более 3 г; 10–50 кг — менее 60 мг/кг, но не более 2 г; менее 10 кг — менее 30 мг/кг | С 12 лет — 3 суток, до 12 лет — 5–7 суток |
| **Парацетамол в ректальных суппозиториях** | 10–14 лет — 500 мг; 5–9 лет — 250 мг; 1–4 года — 100 мг; 3–12 месяцев — 50–100 мг | 4–6 ч | Менее 60 мг/кг | До 5 суток |
| **Ибупрофен внутрь** | Старше 6 лет — 200–400 мг; 4–6 лет — 150 мг; 1–3 года — 100 мг; 3–12 месяцев — 50 мг | 8 ч | 12–17 лет — 1 г; 6–12 лет — 800 мг; 4–6 лет — 450 мг; 1–3 года — 300 мг; 6–12 месяцев — 200 мг; 3–6 месяцев — 150 мг | 4 суток |
| **Ибупрофен в ректальных суппозиториях** | 3–9 месяцев — 60 мг; 9–24 месяца — 60 мг | 8 ч (3–9 месяцев), 6 ч (9–24 месяца) | 3–9 месяцев — 180 мг; 9–24 месяца — 240 мг | Не более 3 суток |

| Препарат | Разовая доза | Интервал | Максимум в сутки | Длительность |
|---|---|---|---|---|
| **Кетопрофен** | С 15 лет — 100 мг внутривенно или внутримышечно | 12 ч | 200 мг | Не более 2 суток |
| **Кетопрофен в гранулах для раствора внутрь** | Старше 6 лет — 40 мг | 8 ч | 120 мг | Не более 2 суток |
| **Метамизол натрия внутримышечно** | 13–14 лет — 0,8–1,8 мл (400–900 мг); 10–12 лет — 0,5–1,0 мл (250–500 мг); 7–9 лет — 0,4–1,0 мл (200–500 мг); 4–6 лет — 0,3–0,8 мл (150–400 мг); 1–3 года — 0,2–0,5 мл; 3–11 месяцев — 0,1–0,2 мл (50–100 мг) | 8–12 ч | С 15 лет — 2 г; 8–14 лет — 900 мг; 4–7 лет — 600 мг; 2–3 года — 300 мг | 1–5 суток |

> В строке метамизола натрия таблицы 2 для детей 1–3 лет указано «0,2–0,5 мл (100–2500 мг)». При концентрации 500 мг в 1 мл, как и в соседних строках, 0,5 мл соответствуют 250 мг, следовательно, значение «2500» является опечаткой. Возраст «79 лет» в той же строке следует читать как 7–9 лет.

### 4.2 Системная антибактериальная терапия (все пациенты)

Всем пациентам с фурункулом, карбункулом и абсцессом носа для санации очага инфекции и предупреждения осложнений проводят системную антибактериальную терапию.

#### Препараты для приёма внутрь

**Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь**

1. взрослые и дети старше 12 лет или массой более 40 кг: 1000 мг (875/125) 2 раза в сутки, 7 дней;
2. дети от 3 месяцев до 12 лет массой менее 40 кг: суспензия (400 мг амоксициллина + 57 мг клавулановой кислоты в 5 мл), 20 мг/кг в сутки (кратность и длительность в КР не указаны);
3. новорождённые и дети до 3 месяцев: 30 мг/кг (по амоксициллину) 2 раза в день, 7–14 дней.

**Цефдиторен**

1. с 12 лет: 200 мг каждые 12 часов, 10 дней.

Тяжёлое или рецидивирующее течение, непереносимость бета-лактамных антибиотиков, пациенты с 18 лет:

1. левофлоксацин: 750 мг один раз в сутки, 7–14 дней;
2. моксифлоксацин: 400 мг один раз в сутки, 7 дней.

#### Препараты для парентерального введения

**Цефазолин: препарат первой линии для парентерального введения**

1. взрослые: 0,5 г внутривенно или внутримышечно 2 раза в день;
2. дети от месяца до 18 лет: 20–50 мг/кг в сутки в 3–4 введения;
3. длительность: 7–10 дней.

**Цефтриаксон, один раз в сутки**

1. взрослые и дети старше 12 лет или массой более 50 кг: 1–2 г;
2. новорождённые до 14 дней: 20–50 мг/кг, не более 50 мг/кг;
3. дети от 15 дней до 12 лет: 20–80 мг/кг;
4. длительность: 7–10 дней.

**Ампициллин + сульбактам внутримышечно или внутривенно (капельно 60–80 капель в минуту или струйно медленно в течение 3–5 минут)**

1. взрослые: 3–12 г в сутки в 3–4 введения в зависимости от тяжести инфекции;
2. дети: 150 мг/кг в сутки в 3–4 введения;
3. недоношенные и дети первой недели жизни: 75 мг/кг в сутки в 2 введения;
4. длительность: 5–14 дней.

**Амоксициллин + клавулановая кислота внутривенно**

1. взрослые и дети старше 12 лет: 1 г (по амоксициллину) 3 раза в сутки;
2. дети до 3 месяцев и массой менее 4 кг: 25/5 мг/кг каждые 8 часов, только медленной инфузией в течение 30–40 минут;
3. дети от 3 месяцев до 12 лет: 25/5 мг/кг каждые 6–8 часов в зависимости от тяжести инфекции;
4. длительность: 5–14 дней.

### Аллергия на бета-лактамные антибиотики

**Клиндамицин**

1. взрослые: парентерально 0,6–2,7 г в сутки в несколько введений;
2. дети 3–18 лет: 20–40 мг/кг в сутки в 3–4 равных приёма;
3. длительность: 7–10 дней.

Детям **младше 3 лет** противопоказан.

### Парентеральные антибактериальные препараты

| Препарат | Разовая доза | Кратность | Максимум в сутки | Длительность |
|---|---|---|---|---|
| **Цефазолин** | Взрослым 0,5 г; детям старше месяца 10–20 мг/кг; внутривенно или внутримышечно | 2 раза в сутки | Взрослым 6 г, детям старше месяца 100 мг/кг | 7–10 дней |
| **Цефтриаксон** | Взрослым 1–2 г; новорождённым до 14 дней 20–50 мг/кг; детям от 15 дней до 12 лет 20–80 мг/кг; внутривенно или внутримышечно | 1 раз в сутки | Взрослым 4 г, детям 2 г | 7–10 дней |
| **Ампициллин + сульбактам** | Взрослым 1–2 г; детям старше месяца 50 мг/кг; новорождённым до 14 дней 75 мг/кг; внутривенно или внутримышечно | Взрослым и детям старше месяца 3 раза, новорождённым 2 раза в сутки | Взрослым 6 г, детям 150 мг/кг | 5–14 дней внутримышечно (или 5–7 дней внутривенно, затем внутримышечно до 14 дней) |
| **Амоксициллин + клавулановая кислота** | Взрослым и детям старше 12 лет 1 г внутривенно; до 12 лет 25 мг/кг внутривенно | Взрослым и детям старше 3 месяцев 3 раза, детям до 3 месяцев 2–3 раза в сутки | Взрослым и детям старше 12 лет 6 г, до 12 лет 50–75 мг/кг | 5–14 дней |

| Препарат | Разовая доза | Кратность | Максимум в сутки | Длительность |
|---|---|---|---|---|
| **Клиндамицин** | Взрослым «0,2–0,9 мг» (так в таблице; внутримышечно не более 0,6 г, внутривенно не более 1,2 г на одно введение); детям 3–18 лет 5–10 мг/кг внутримышечно или внутривенно | 3–4 раза в сутки | Взрослым 4,8 г, детям 40 мг/кг | 7–10 дней |

Данные раздела 3.1 и таблицы 3 не совпадают. Цефазолин детям: в тексте 20–50 мг/кг в сутки в 3–4 введения, в таблице 10–20 мг/кг 2 раза в сутки. Ампициллин с сульбактамом: в тексте взрослым до 12 г в сутки, в таблице максимальная доза 6 г; новорождённым в тексте 75 мг/кг в сутки в 2 введения, в таблице 75 мг/кг на введение 2 раза в сутки. Амоксициллин с клавулановой кислотой детям: в тексте 25 мг/кг каждые 6–8 часов (до 100 мг/кг в сутки), в таблице максимальная доза 50–75 мг/кг в сутки. Разовая доза клиндамицина взрослым в таблице указана в миллиграммах («0,2–0,9 мг»), хотя, исходя из смысла и текста (0,6–2,7 г в сутки), речь идёт о граммах.

### 4.3 Стадия абсцедирования, карбункул, абсцесс: хирургическое лечение

Показания к хирургическому лечению:

1. стадия абсцедирования;
2. карбункул носа.

При осложнённом течении абсцесс или карбункул носа вскрывают, чтобы эвакуировать гной и обеспечить дренирование.

Вмешательство возможно как под местной анестезией, так и под общим обезболиванием. Забор материала из раны для бактериологического исследования обязателен.

### 4.4 Осложнённое течение: антикоагулянтная терапия

Осложнённое течение фурункула, карбункула или абсцесса носа во всех случаях требует профилактики тромбозов антикоагулянтами прямого или непрямого действия.

Доза подбирается под контролем показателей свёртывающей системы крови.

### 4.5 Стадия разрешения

В стадии разрешения для ускорения выздоровления показана консультация физиотерапевта.

---

## 5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

### 5.1 Рецидивирующее течение

При рецидивирующих фурункулах носа рекомендована консультация эндокринолога (у детей детского эндокринолога) для выявления причины рецидивов.

В ряде случаев целесообразна также консультация аллерголога-иммунолога.

Для профилактики рецидивов при рецидивирующем течении фурункула носа применяют бактериофаги.

Местное применение бактериофагов в комплексном лечении оправдано при устойчивости выделенных штаммов к антибиотикам, при наличии в анамнезе более двух курсов антибактериальной терапии, при непереносимости антибиотиков и при рецидивирующем течении.

### 5.2 Профилактика

**Основа профилактики**

1. личная гигиена: мытьё рук до и после еды, после туалета, поездок в транспорте и посещения общественных мест;
2. гигиена труда, средства защиты при работе в условиях запылённости и загрязнения;
3. запрет прикосновений к коже лица грязными руками, массажа болезненных участков, выдавливания фурункула и самолечения;
4. при сахарном диабете и других заболеваниях соблюдение диеты и своевременный приём препаратов;
5. обучение гигиеническим навыкам в семье, детском саду и школе.

**Пациенту разъясняют**

1. осторожность при косметическом уходе за лицом, включая чистку лица и бритьё;
2. при гнойничке на коже носа или верхней губы массаж и выдавливание категорически противопоказаны;
3. при отёке или гиперемии в области фурункула обращаться в оториноларингологический стационар.

**Родителям**

1. контролировать чистоту рук ребёнка;
2. обучать правильному туалету носа;
3. не допускать ковыряния в носу.

### 5.3 Показания к госпитализации

**Показания к госпитализации**

1. дети: установленный диагноз абсцесса, фурункула или карбункула носа (круглосуточный оториноларингологический стационар).

Взрослые в стадии инфильтрации могут лечиться у оториноларинголога амбулаторно. В большинстве случаев пациентов ведёт оториноларинголог в хирургическом стационаре.

Вслед за разрешением амбулаторного лечения КР отдельно упоминает пациентов в стадии инфильтрации с сопутствующими (коморбидными) заболеваниями и пациентов с рецидивирующими фурункулами; фраза не закончена, тактика не указана, по контексту такие пациенты к амбулаторному лечению не отнесены.

> В разделе 6 фраза о пациентах с сопутствующими заболеваниями и рецидивирующими фурункулами не закончена и тактика их ведения не указана; по контексту, по-видимому, подразумевается госпитализация. Кроме того, в информации для пациента (приложение В) при отёке или гиперемии в области фурункула всем пациентам рекомендуется обращаться в оториноларингологический стационар, хотя гиперемия и отёк отмечаются уже в стадии инфильтрации, при которой взрослые, согласно разделу 6, могут получать лечение амбулаторно.

**Показания к выписке**

1. разрешении абсцесса, фурункула или карбункула;
2. отсутствии осложнений;
3. удовлетворительном общем состоянии;
4. нормализации температуры тела.

При неосложнённом течении прогноз благоприятный. У пациентов с первичным или вторичным иммунодефицитом и с сахарным диабетом следует ожидать более тяжёлого течения и высокого риска осложнений.

## 6. Источник и актуальность

| | |
|---|---|
| Документ | Клинические рекомендации «Абсцесс. Фурункул носа. Карбункул носа» |
| Версия | 1-я, опубликована в рубрикаторе 14.10.2025 |
| Статус | **Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026) |
| Актуализация | По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2028 года |
| Код в рубрикаторе | 956_1 · открыть текст КР ↗ |
| Разработчик | Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов |
| Пациенты | Взрослые и дети |

### 6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В таблице 1 разовая доза диклофенака указана как «75 мл».
- В таблице 2 для метамизола натрия у детей 1–3 лет указано «100–2500 мг» (объёму 0,2–0,5 мл соответствуют 100–250 мг), а возраст «79 лет» означает 7–9 лет.
- Дозы антибактериальных препаратов в тексте раздела 3.1 и в таблице 3 не совпадают: доза цефазолина у детей, максимальная доза ампициллина с сульбактамом у взрослых и его доза у новорождённых, суточная доза амоксициллина с клавулановой кислотой у детей.
- Разовая доза клиндамицина взрослым в таблице 3 указана как «0,2–0,9 мг» вместо граммов; в тексте фраза «противопоказан детям в возрасте старше до 3-х лет» искажена (по контексту имеется в виду возраст младше 3 лет).
- Состав консультантов при внутричерепных осложнениях в разделе 2.5 и в критериях качества (невролог, офтальмолог) не совпадает с алгоритмом в приложении Б (нейрохирург, офтальмолог, челюстно-лицевой хирург).
- В разделе 6 фраза о пациентах с сопутствующими заболеваниями и рецидивирующими фурункулами не закончена; рекомендация из приложения В обращаться в стационар при любом отёке или гиперемии расходится с возможностью амбулаторного лечения взрослых в стадии инфильтрации.
- Показания к хирургическому лечению сформулированы по-разному: в разделе 3.2 указаны абсцедирование и карбункул, в тезисе-рекомендации указано осложнённое течение, в критериях качества указана стадия абсцедирования.